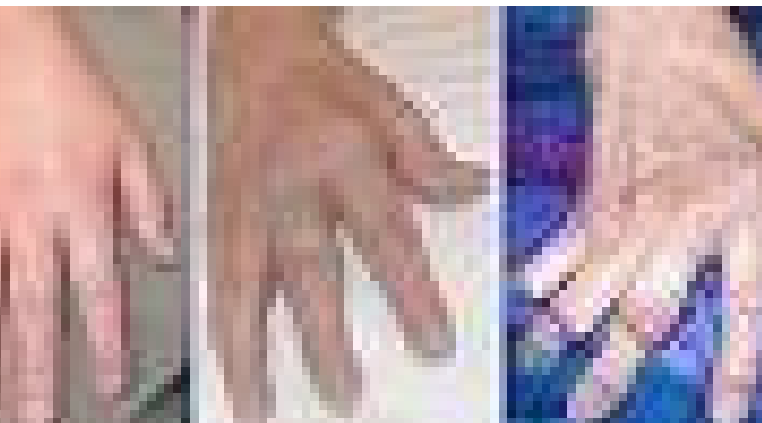
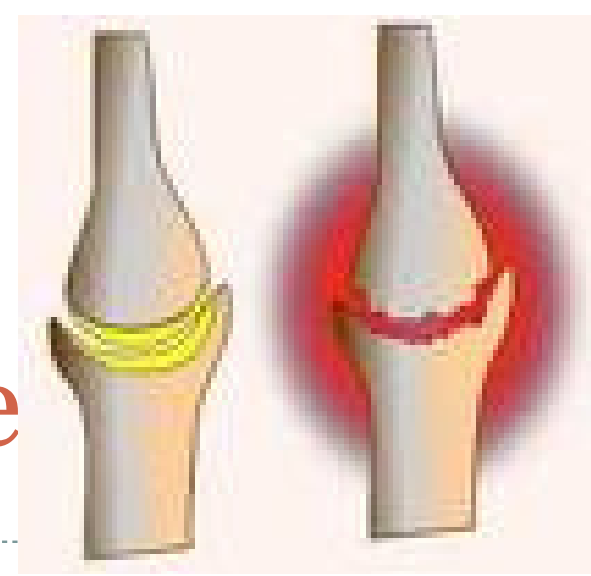




Sémiologie rhumatologique



PR S. BENSALEM
MÉDECINE INTERNE
C.H.U. IBN BADIS

INTRODUCTION



- La rhumatologie étudie les maladies de l'appareil locomoteur : articulations, rachis, formations juxta articulaires, os et muscles

Anatomie



Les constituants de l'articulation



- le cartilage articulaire : la seule structure fonctionnelle de l'articulation:
- tissu très différencié, avasculaire, pauvre en cellules. il est constitué par les fibres collagènes (collagène type II), le chondrocyte et la substance fondamentale.
- Il se compose de trois couches :
 - la couche superficielle
 - la couche moyenne la plus épaisse
 - la couche profonde calcifiée qui fait la transition avec la plaque sous chondrale



-La membrane synoviale

- Elle recouvre toutes les structures intra-articulaires sauf le cartilage et les ménisques
- Elle a un rôle de macrophage, capable de débarrasser la cavité articulaire des débris anormaux. Elle opère également la filtration du sérum pour constituer le liquide synovial.
- Elle sécrète des substances diverses parmi lesquelles l'acide hyaluronique, des protéoglycanes et des enzymes protéolytiques.



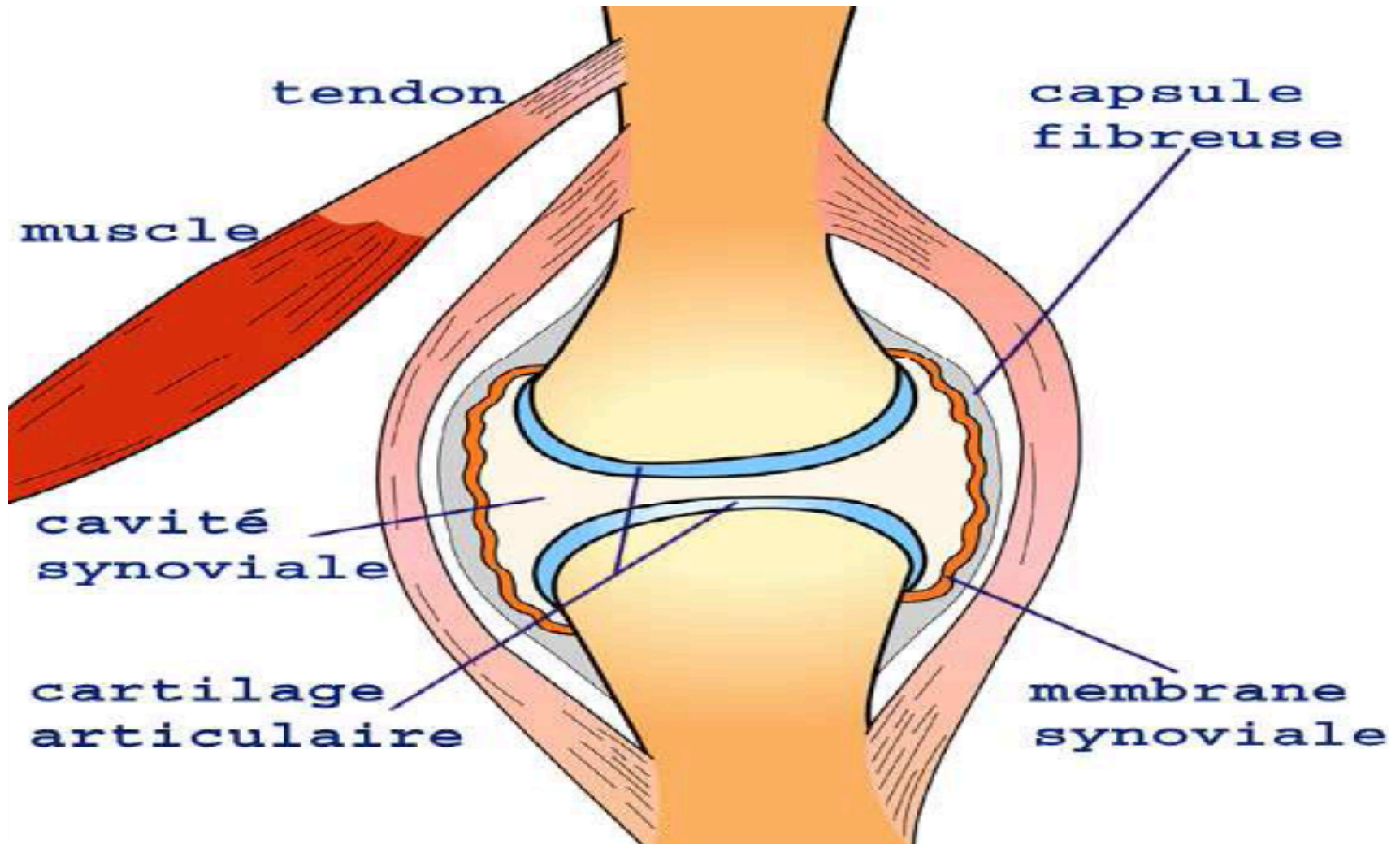
-Les bourses séreuses

- Cavités closes qui facilitent le glissement de structures anatomique l'une sur l'autre.

- Le liquide synovial

- Présent en très faible quantité dans une articulation. Il contient environ 200 cellules mononuclées de type macrophagique par millilitre.
- Les muscles, les tendons, la capsule et les ligaments

Rappel anatomique d'une articulation normale



EXAMEN CLINIQUE D'UN MALADE ATTEINT D'UNE AFFECTION ARTICULAIRE



- Les maladies ostéo-articulaires mettent rarement en jeu le pronostic vital, en revanche, elles compromettent rapidement le pronostic fonctionnel et retentissent sur l'activité professionnelle, puis sur l'activité quotidienne des malades,
- **la notion de pronostic fonctionnel** doit donc occuper une place importante dans l'examen de ces patients car elle guide les indications thérapeutiques

Interrogatoire



- La profession: en détaillant l'activité physique qu'elle nécessite;
- Les sports pratiqués;
- Les traumatismes subis;
- Les antécédents rhumatologiques et médicaux personnels et familiaux;
- Les traitements suivis et les médicaments utilisés (pathologie iatrogène , interactions médicamenteuses);
- Les antécédents digestifs personnels à type d'ulcère gastro-duodénal, car les traitements utilisés en rhumatologie comportent très souvent le risque d'accidents digestifs

La douleur



- Le mode de début: progressif , rapide ou brutal
- le siège et les irradiations notamment pour les douleurs radiculaires
- l'intensité(difficile à faire préciser): échelle visuelle analogique(EVA), éventuellement se fonder sur la quantité d'antalgiques nécessaires pour la calmer
- Les circonstances déclenchantes
- L'horaire dans la journée: c'est un point très important car il permet d'opposer les douleurs mécaniques et inflammatoires

La douleur



Douleur mécanique :

maximale en fin de journée totalement calmée par le repos :
le sujet ne souffre pas la nuit

- Elle peut apparaître le matin lorsque le sujet se lève
s'atténuer en quelques minutes de mobilisation :
dérouillage matinal rapide , reste sourde dans la journée



Douleur inflammatoire :

le patient souffre la nuit , surtout au cours de la deuxième moitié

- La douleur persiste le matin au réveil avec une raideur matinale et un temps de dérouillage prolongé > à 30 mn parfois plusieurs heures.
- Elle n'est pas calmée par le repos et cède mal à la mobilisation.
- Elle ne disparaît pas totalement dans la journée.
- Rythme de la douleur: permanente ou évoluant par poussée

La gêne fonctionnelle



- Elle est fonction de deux facteurs: la douleur et la limitation de la mobilité .
- Il importe d'apprécier la gravité de cette gêne fonctionnelle et son retentissement sur les activités professionnelles .

EXAMEN PHYSIQUE



- Il porte sur un malade **déshabillé**.
- Dans un premier temps, il faut apprécier la stature générale du sujet , son poids, sa taille
- L'examen rhumatologique doit toujours être méthodique
- L'examen d'abord de la marche, du squelette axial, des articulations périphériques
- il doit toujours être terminé par un examen somatique complet.

L'inspection



- Elle apprécie:
- La coloration des téguments: normale, rosée ou franchement rouge
- La morphologie globale de la jointure: normale, déformée par des reliefs anomaux, siège de subluxation, de luxation, trouble de l'axe du membre attitude vicieuse

L'articulation peut être noyée dans un œdème qui fait disparaître les reliefs anatomiques.

LA PALPATION



- Elle recherche:
- Une modification de la chaleur locale
- La distension de l'articulation par un épanchement intra-articulaire (hydarthrose)
- Des points douloureux en regard des repères anatomiques
- Préciser l'origine de la douleur: articulaire, péri articulaire ou osseuse

la mobilisation :



- Elle doit se faire avec douceur
- Elle est réalisée en mobilisant les segments de membre l'un par rapport à l'autre , dans toutes les directions physiologiques

On note :

- l'existence de douleurs de la mobilisation

- La limitation par la douleur ou par l'ankylose invincible

La mobilité passive (l'examineur qui exerce le mouvement)
la mobilité active (le malade effectue le mouvement)
la mobilité contrariée c'est-à-dire contre résistance .

Le reste de l'examen



- L'examen local établit l'état des muscles , des artères et des veines .
- L'examen régional , concerne les articulations sus et sous jacentes, les ganglions drainant l'articulation
- L'examen des autres articulations et du rachis pour savoir si l'atteinte est mono articulaire (une seule articulation) , oligo-articulaire (<4 articulations) ou polyarticulaire (≥ 4 articulations)

Signes radiologiques



Signes radiologiques	Pathologie mécanique (arthrose)	Pathologie inflammatoire (arthrite)
	Pincement électif, asymétrique Ostéophytes Condensation sous chondrale Géodes sous chondrales	Tuméfaction des parties molles Déminéralisation de l'os sous chondral Petites géodes Pincement global tardivement

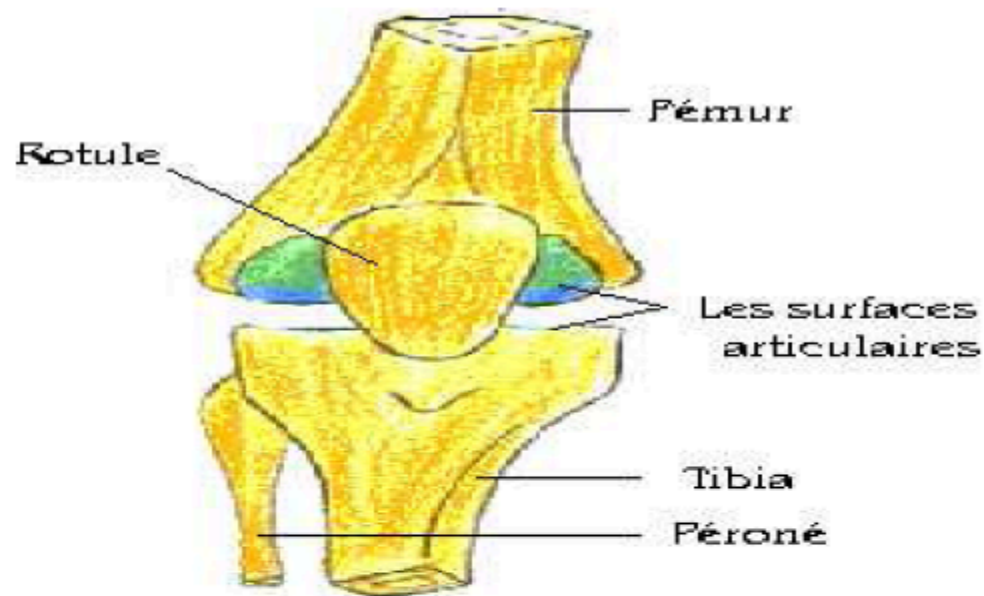


L'articulation du genou

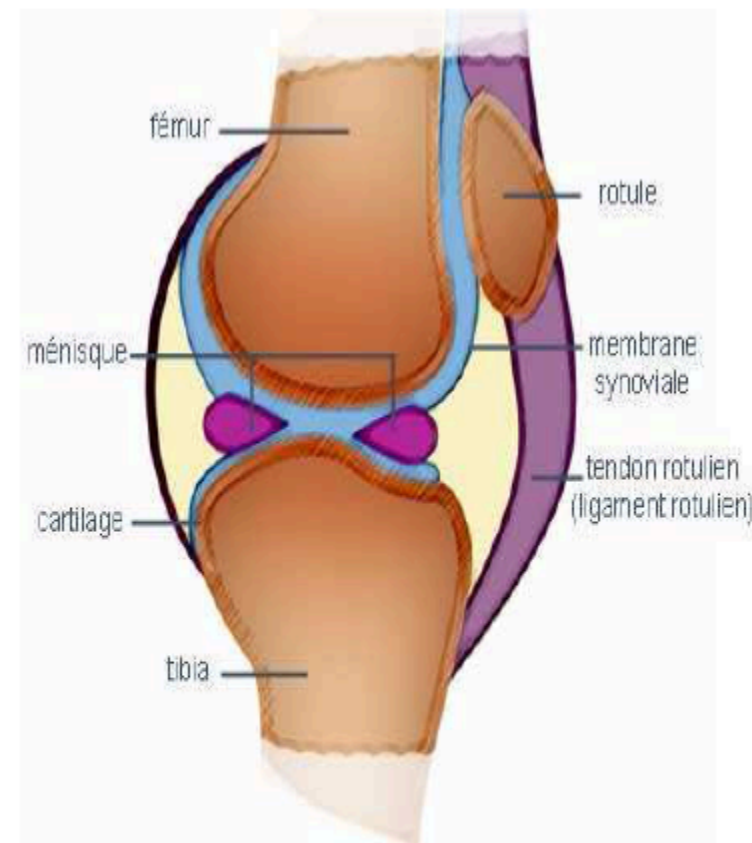
GENOU ET PONCTION ARTICULAIRE

Le genou est une articulation superficielle et portante.

Il est constitué de deux articulations : la fémoro-tibiale et la fémoro-patellaire.



Genou de face



A / Interrogatoire



Antécédents:

- circonstances d'apparition (traumatisme....) ,
- pathologie médicale ou chirurgicale,
- prise médicamenteuse...

A / Interrogatoire



- **Douleur:**

- caractère mécanique ou inflammatoire;
- mode d'apparition: aiguë ou chronique.
- intensité: à évaluer par L'EVA (échelle visuelle analogique).
- siège: à faire préciser par le doigt du patient
- irradiation: rare au niveau du genou; surtout se méfier d'une douleur projetée (cruralgie ou origine coxo-fémorale).

D'où la règle d'examiner systématiquement la hanche devant toute douleur du genou.

- effet d'éventuels traitement pris.



Blocage:

- Vrai : (en flexion) impossibilité d'étendre complètement le genou pendant quelques minutes (témoin d'une lésion méniscale).
- Pseudo: de durée brève
(témoin d'une lésion cartilagineuse)

Dérobement:

- genou qui lâche en particulier: en escaliers ou sur terrain accidenté.

B / Examen d'un genou



1) Position debout : recherche de troubles statiques.

❖ **plan frontal**

Genu varum : genoux écartés, mesure de la distance inter condylienne interne.



➤ **Genu valgum** : genoux qui se touchent, mesure de la distance intermalléolaire interne des deux chevilles.

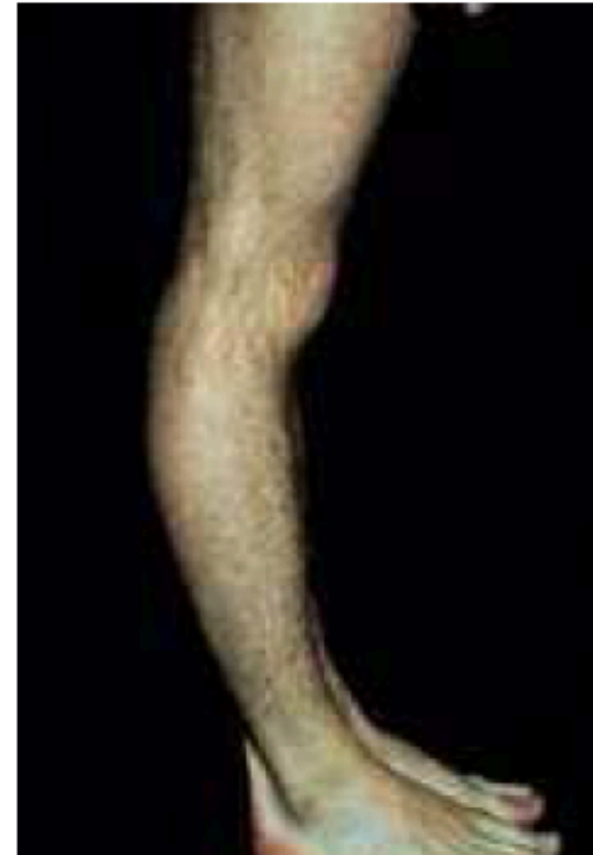


Plan sagittal

- **Genu flexum :**
impossibilité d'étendre complètement le genou.



- **Genu recurvatum :**
Hyperextension du genou



B / Examen d'un genou



2) Position couchée :

a) Inspection comparative :

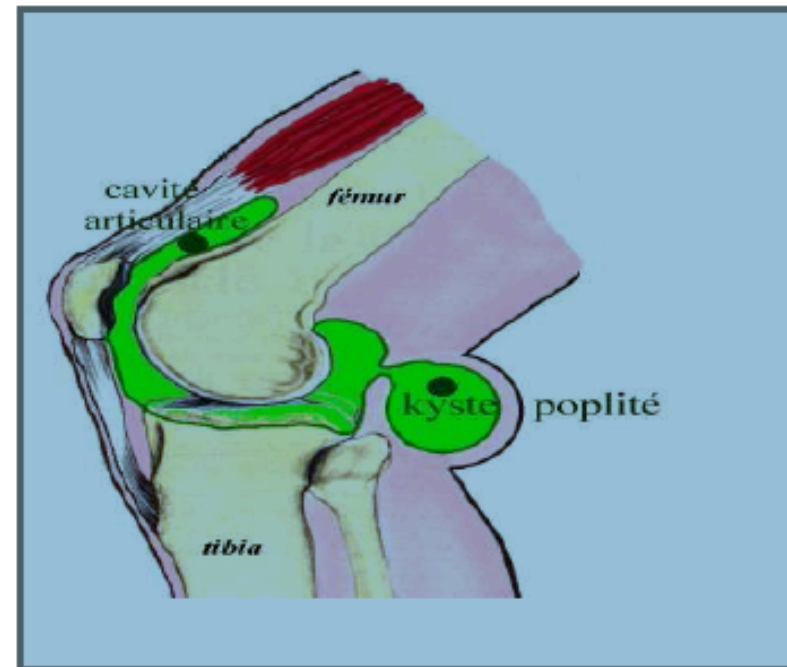
mise en évidence d'un gros genou : comblement des culs de sac quadricipitaux et disparition des méplats latéraux et sus rotuliens.

b) Palpation : recherche d'un épanchement intra articulaire

a- inspection comparative :

mise en évidence d'un gros genou : comblement des culs de sac quadricipitaux et disparition des méplats latéraux et sus rotuliens.

b - palpation : recherche d'un épanchement intra articulaire.



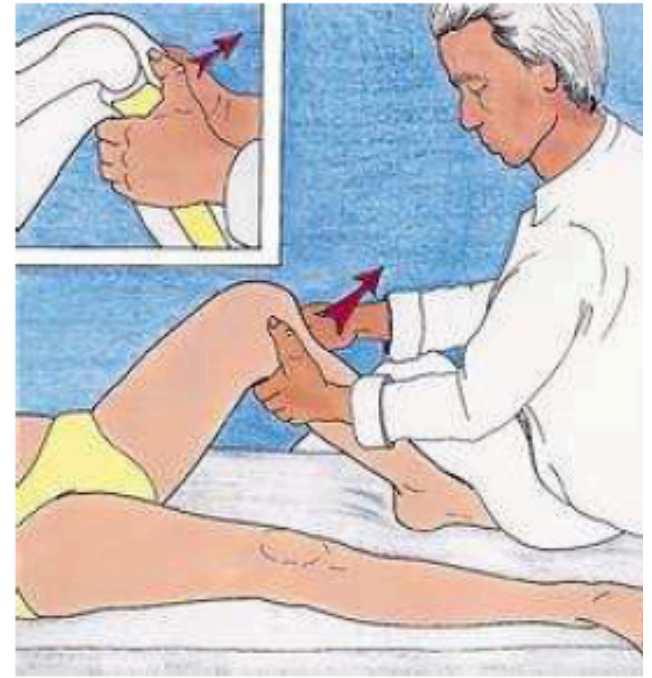
Technique.



- Patient en décubitus dorsal, genou en extension: avec les deux mains on exerce une pression sur les culs de sac latéro- rotuliens et sous quadricipital de façon à concentrer la plus grande quantité du liquide sous la rotule; on exerce alors une pression sur la face antérieure de la rotule qui vient buter sur la trochlée créant un choc comme un glaçon dans l'eau c'est le **choc rotulien**.
- La palpation du creux poplité (mieux en décubitus ventral genou fléchi à 90°) à la recherche d'un **Kyste poplité**

f- recherche de mouvements anormaux :

- Tiroirs : antérieur et postérieur, test de Lachman ; si la manœuvre est positive elle témoigne d'une lésion du LCA ou LCP (ligament croisé antérieur ou postérieur).
- Mouvements de latéralité : interne ou externe.
- Lésions méniscales: Manœuvres méniscales (Grinding test d'Apley...)



C / Ponction Articulaire



- Complément de l'examen clinique
- Systématique devant tout épanchement (sauf hémophilie et troubles de la coagulation).
- Nécessité des mesures d'asepsie rigoureuse: se laver les mains , matériel stérile à usage unique, badigeonnage par un produit iodé (Bétadine)....

Liquide de ponction



Liquide mécanique

- clair,jaune citrin
- Visqueux
- pauvre en cellules<1000GB/par mm₃(<50%de PNN)

Liquide inflammatoire

- Jaune foncé, trouble, parfois purulent
- Fluide.
- Riche en cellules>2000GB/mm₃(>50%de PNN)

Le liquide hémorragique (qui ne coagule pas) doit faire l'objet d'analyse cytologique bactériologique